

KC桌面——外资精译

GS：从PDE34到干粉剂型，中国生物制药差异化竞争起步

与跨国药企的第二笔BD交易；将PDE3/4i授权给阿斯利康：中国生物制药宣布与阿斯利康就TQC3721（一种处于三期临床的PDE3/4抑制剂）达成许可协议。根据协议，阿斯利康获得TQC3721的中国境外权益，需支付2亿美元首付款，以及最高17亿美元的开发、注册和商业里程碑付款，并基于净销售额支付最高达两位数的分级特许权使用费。此外，阿斯利康还获得了TQC3721某些未来开发项目的全球权益，据公司称，这些项目比正在进行的临床项目更具创新性。TQC3721成为继2025年恒瑞医药与葛兰素史克就其PDE3/4抑制剂达成交易后，第二个获得大型跨国药企合作的中国原研PDE3/4抑制剂。这笔交易标志着中国生物制药继早前与赛诺菲合作后，在2026年与跨国药企达成的第二笔重大对外授权交易，进一步证明了公司从其内部研发平台培育具有全球竞争力资产的能力。

引入葛兰素史克两款COPD药物以加强呼吸产品组合：除了TQC3721对外授权交易外，公司还宣布在与葛兰素史克就bepirovirsen合作的基础上，扩大合作伙伴关系。通过从葛兰素史克引入Trelegy（LABA/LAMA/ICS）和Anoro（LABA/LAMA），初始合作期为5.5年，中国生物制药进一步丰富了其呼吸产品组合。该组合目前包括30多个已上市的呼吸产品，并由一支超过2000人的专职呼吸销售团队支持，覆盖全国9000多家医院。这两个产品在2025年的全球合并销售额接近50亿美元，而目前在中国市场的总销售额仍低于10亿元人民币，表明存在巨大的渗透和市场份额增长空间。更重要的是，这些产品非常适合中国生物制药现有的COPD治疗矩阵，并增强了公司为从急性发作到维持治疗的全谱系COPD患者提供服务的能力。展望未来，我们相信该商业平台能与公司内部研发的呼吸管线（包括TQC3721（PDE3/4抑制剂）、TSLP单克隆抗体（TQC2731）和IL-4Ra单克隆抗体（TQH2722））产生显著的协同效应。

TQC3721与ensifentrine疗效相当，DPI剂型形成差异化：基于二期数据，TQC3721在3mg和6mg剂量组中，第4周经安慰剂校正的FEV1改善分别约为+100mL和+147mL。在非头对头比较中，这一疗效与先发药物ensifentrine 3mg报告的+124mL经安慰剂校正的FEV1改善基本相当（见图表1）。此外，TQC3721显示出令人鼓舞的安全性特征，研究中未报告因治疗而停药的情况。除了疗效，我们认为TQC3721的干粉吸入剂（DPI）可能是一个关键的差异化优势，具有更好的便利性。虽然ensifentrine目前作为雾化疗法上市，但中国生物制药正在同时推进TQC3721的雾化和DPI两种剂型，其中DPI版本正处于二期开发阶段，一期数据预计将于2026年下半年读出。

不断演变的COPD治疗：旨在覆盖更广泛的患者群体/长效药物：与已获批用于COPD的生物制剂（如度普利尤单抗和美泊利珠单抗）相比，PDE3/4抑制剂有可能覆盖更广泛的COPD人群，因为目前的生物制剂主要聚焦于具有2型炎症和嗜酸性粒细胞计数升高的患者，而这仅占COPD患者的一小部分。然而，竞争格局正在迅速演变。阿斯利康的tozorakimab（IL-33单抗）已取得积极的三期结果，并且似乎能够治疗超越传统嗜酸性粒细胞亚型的广泛COPD人群，这可能会缩小PDE3/4抑制剂的一个关键差异化优势。展望未来，下一代长效生物制剂可能成为另一股颠覆性力量。例如，科济药业的CM512（TSLP/IL13双特异性抗体）的目标是潜在的3-6个月给药间隔，预计将于2026年底发布COPD二期数据，这可能进一步将治疗模式转向更广泛的覆盖和更高的便利性。

估值与盈利预测调整：交易公告后，我们计入了阿斯利康交易在2026年下半年的首付款，并引入了Trelegy和Anoro的销售预测。我们预计这两个产品在2026/27/28年的合计销售额分别为12亿/14亿/17亿元人民币（2026年仅反映第四季度销售额）。因此，我们对2026/27/28年的盈利预测分别上调了+6.9%/+2.6%/+2.7%。鉴于已确定全球合作伙伴，我们将PDE3/4i的成功概率从80%上调至100%。基于更新后的预测和成功概率。

图表1：COPD临床数据比较

来源：美国呼吸与危重症医学杂志，美国胸科医师学会，新英格兰医学杂志

公司情况更新

。；2) 仿制药：基于10.0倍退出市盈率和5%的5年复合增长率的估值502亿港元；3) 安罗替尼和PD-(L)1：基于DCF的估值60亿港元。主要节奏变化不确定性：1) 仿制药组合更广泛的降价；2) 管线中关键产品的监管审批延迟；3) 因资源分配不当导致研发回报表现率低；4) 创新药放量不及预期。

中国生物制药是中国领先的制药公司，业务涵盖创新药和仿制药。其关键重点领域包括肝炎、肿瘤、心脑血管、骨科、呼吸和镇痛适应症。自2019年以来，由于集采实施对肝炎药物的谨慎影响大部分已得到体现，我们预计未来集采对公司的影响为中性，因为公司预计在未来三年内推出100多种新仿制药以提供增量销售。虽然鉴于集团内子公司资源分配的挑战，我们对公司的研发进展持谨慎态度，但我们认为公司近期驱动力来自即将上市的新创新药，包括PD-1/L1、G-CSF、ROS1、ALK抑制剂、bepirovirsen和多种生物类似药。我们更新公司观点，因为我们预计未来两年盈利增长具有韧性，并且鉴于其强劲的现金余额，可能会有更多BD交易。该股目前处于其5年历史区间的低端。主要不确定性：1) 仿制药组合更广泛的降价；2) 管线中关键产品的监管审批延迟；3) 因资源分配不当导致研发回报表现率低；4) 创新药放量不及预期。

来源：公司数据，GS预测，FactSet。价格截至2026年7月8日收盘。

附录：公司情况更新

Reg AC

GS因子概况

GS因子概况通过将公司的关键属性与市场（即我们的评级公司池）及其行业同行进行比较，提供研究背景。所描绘的四个关键属性是：增长、财务回报、倍数（例如估值）和综合（增长、财务回报和倍数的组合）。增长、财务回报和倍数是通过使用每只公司特定指标的标准化排名来计算的。然后对指标的标准化排名进行平均，并转换为相关属性的百分位数。每个指标的具体计算可能因财年、行业和地区而异，但标准方法如下

增长基于公司的前瞻性销售增长、EBITDA增长和每股收益增长（对于资金股，仅每股收益和销售增长），百分位数越高表示公司增长越高。财务回报基于公司的前瞻性ROE、ROCE和CROCI（对于资金股，仅ROE），百分位数越高表示公司财务回报越高。倍数基于公司的前瞻性市盈率、市净率、价格/股息（P/D）、EV/EBITDA、EV/FCF和EV/债务调整后现金流（DAFCF）（对于资金股，仅市盈率、市净率和P/D），百分位数越高表示公司交易倍数越高。综合百分位数计算为增长百分位数、财务回报百分位数和（100% - 倍数百分位数）的平均值。

财务回报和倍数使用GS分析师对未来至少三个季度后的财年末预测。增长使用未来至少七个季度后的财年输入数据，与未来至少三个季度后的财年进行比较（所有指标均基于每股）。

有关我们如何计算GS因子概况的更详细描述，请联系您的GS代表。

并购排名：公司情况更新

在我们的全球覆盖范围内，我们使用并购框架审视公司，同时考虑定性因素和定量因素（可能因行业和地区而异），以纳入某些公司可能被收购的潜力。然后我们分配一个并购排名，作为对我们评级覆盖下的公司进行评分的方法，从1到3，其中1表示公司成为收购目标的可能性高（30%-50%），2表示可能性中等（15%-30%），3表示可能性低（0%-15%）。对于排名为1或2的公司，按照我们标准部门指南。并购排名为3被视为不重要，并且可能在研究中讨论或不讨论。

Quantum

Quantum是GS专有数据库，提供详细的财务报表历史、预测和比率访问。它可用于对单一公司进行深入分析，或比较不同行业和市场公司。